股骨头坏死中医疗效评价标准

项目编号：xxxxxxxxx

编制说明

提出单位：中华中医药学会

归口单位：中华中医药学会

项目承担单位：中国中医科学院望京医院

项目工作组成员：陈卫衡，何伟，赵德伟，童培建，李子荣，詹红生，林娜，王义生，李盛华，董晓俊，刘又文，沈计荣。

二〇一九年二月

目　录

1. 工作简况 1

2. 指南编制原则和确定标准主要内容的依据 6

3. 与相关法律、法规和强制性标准的关系 12

4. 重大意见的处理经过和依据 12

5. 贯彻标准的要求和措施建议 14

6. 应当说明的其他事项 15

附件 1 16

《股骨头坏死中医疗效评价标准》专家调查问卷总结 16

附件 2 19

《股骨头坏死中医疗效评价标准》项目启动会 19

《股骨头坏死中医疗效评价标准》草案专家讨论会（北京）..... 20

《股骨头坏死中医疗效评价标准》专家咨询会（北京） 21

《股骨头坏死中医疗效评价标准》专家论证会（北京） 23

《股骨头坏死中医疗效评价标准》征求意见表决会（北京）..... 24

附件 3 26

《股骨头坏死中医疗效评价标准》同行征求意见总结 26

1. 工作简况

1.1 任务来源

为了贯彻落实2015年3月国务院印发的《深化标准化工作改革方案》，国家标准委员会办公室决定开展团体标准试点工作。试点工作期间，为促进国内外股骨头坏死中医疗效评价标准方案的规范化，为规范股骨头坏死中医疗效评价标准，构建统一的疗效评价标准提供可靠证据，确保治疗的安全性和有效性。立项开展了股骨头坏死中医疗效评价标准的制订工作。本指南由中华中医药学会提出并归口，中国中医科学院望京医院承担起草，项目负责人陈卫衡。本项目计划于2019年2月完成。

1.2 协作单位

中国中医科学院望京医院为本项目的主要完成单位，协作单位有广州中医药大学第一附属医院、大连大学附属中山医院、浙江省中医院、中日友好医院、上海曙光医院、中国中医科学院中药研究所、郑州大学第一附属医院、甘肃省中医院、武汉市中医院、洛阳正骨医院、江苏省中医院、福建中医药大学。

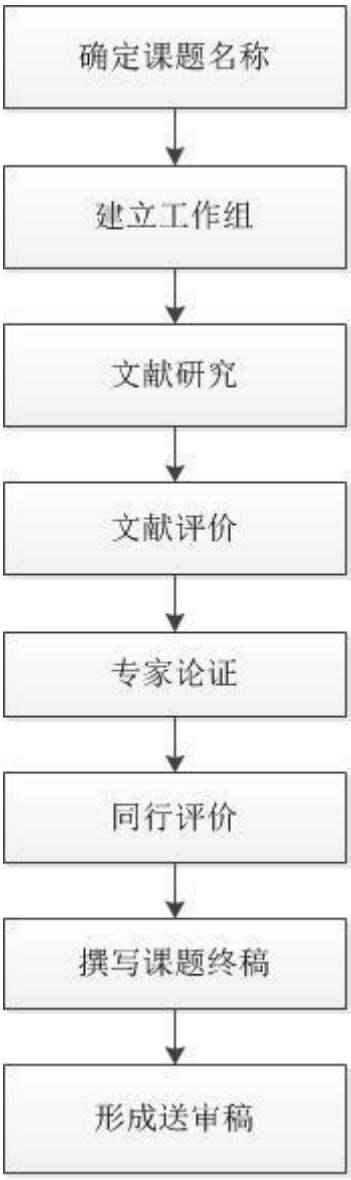
1.3 主要工作过程

2017年在中华中医药学会组织下，于6月成立了以中国中医科学院望京医院为主要起草单位，广州中医药大学第一附属医院、大连大学附属中山医院、福建中医药大学、浙江省中医院、中日友好医院、上海曙光医院、中国中医科学院中药研究所、上海新华医院、郑州大学第一附属医院、甘肃省中医院、武汉市中

医院、洛阳正骨医院、江苏省中医院参加起草的指南工作组，工作组起草人由陈卫衡，何伟，赵德伟，童培建，李子荣，詹红生，林娜，王义生，李盛华，董晓俊，刘又文，沈计荣等组成。6月～8月工作组完成文献研究报告：统计分析股骨头坏死疗效评价术语；文献计量研究方法搜集统计分析中医药疗法治疗股骨头坏死的疗效评价文献。2017年8月由本标准主要起草单位与其他30家协作单位共同召开了《股骨头坏死中医疗效评价标准》项目启动会，规范股骨头坏死疗效评价术语；探讨中医药疗法治疗股骨头坏死的疗效评价内容。2018年1月～3月，工作组成员开始起草股骨头坏死中医疗效评价标准，专家咨询探讨结合现有标准起草《股骨头坏死中医疗效评价标准》草案。2018年3月初项目工作组于北京再次召开专家论证会，项目组采用股骨头坏死专题会议方式广泛征求同行对《股骨头坏死中医疗效评价标准》草案建议并对标准草案进行修改。2018年5月项目工作组于北京召开专家咨询会，项目组根据3月草案讨论会专家咨询结果重新遴选股骨头坏死中医疗效评价标准的结局指标。2018年7月项目组召开《股骨头坏死中医疗效评价标准》初稿讨论会，征求对《股骨头坏死中医疗效评价标准》的初稿修改意见。2018年11月项目组于北京召开《股骨头坏死中医疗效评价标准》同行专家评审会，广泛征求对《股骨头坏死中医疗效评价标准》同行意见。项目工作组先后通过6轮现场及2轮电子问卷共发放254份问卷，收回251份问卷，共149位中医专家与102位西医专家参加问卷调

查，专家积极系数98.81%。并于草案讨论会后根据专家建议对103位股骨头坏死患者与72位医师进行问卷调查，记录200例股骨头坏死患者关节活动度。项目工作组按照“循证”等原则逐条讨论了专家们的意见，提出了采纳、不采纳的意见及理由，以之为依据，对征求意见稿进行修改。2019年2月完成《股骨头坏死中医辨证标准》，提交中华中医药学会审批发布。

本次指南制订的编制过程如下：



1.4 指南主要起草人及其所做工作

标准主要起草人及其所做的工作					
姓名	学位	单位	职务	职称	工作内容
陈卫衡	博士	中国中医科学院望京医院	骨科主任	主任医师	《股骨头坏死中医疗效评价标准》负责人。组织申报、实施、总结。
何伟	博士	广州中医药大学第一附属医院	副院长	主任医师	标准起草
赵德伟	博士	大连大学附属中山医院	院长	主任医师	标准起草
童培建	博士	浙江省中医院	骨科主任	主任医师	标准起草
李子荣	硕士	中日友好医院	骨科主任	主任医师	标准起草
詹红生	博士	上海曙光医院	骨科主任	主任医师	标准起草
林娜	博士	中国中医科学	研究室主	研究	标准起草

		院中药研究所	任	员	
王义生	硕士	郑州大学第一附属医院	骨科主任	主任医师	标准起草
李盛华	硕士	甘肃省中医院	院长	主任医师	标准起草
董晓俊	学士	武汉市中医院	骨科主任	主任医师	标准起草
刘又文	学士	洛阳正骨医院	骨科主任	主任医师	标准起草
沈计荣	硕士	江苏省中医院	骨科主任	主任医师	标准起草

2.指南编制原则和确定标准主要内容的依据

2.1 指南编制原则

本指南编制遵循“科学性、实用性、规范性”原则，按照“能够为中医行业内实际应用，能被行业外广泛接受和认可，并与国际诊疗指南接轨”的要求。

2.1.1 科学性

科学性是编制本指南的前提，也是保障指南质量的基础。本指南在编制过程中，严格遵循科学性原则。

本团队采用了具有中医药特色的“文献研究法”、“专家问卷调查法（Delphi 法）”、“专家会议法”三法合一的研究方法，保证了诊疗指南的科学性。

采用了中医药标准化研究团队中医循证指南研制的“文献研究法”，包括“文献检索”、“文献综述”、“文献评价”3个方面的内容。其中“文献检索”按国际通行要求方法进行，要求查找古今中外与股骨头坏死相关文献；“文献综述”提出了保证指南研制质量的工作要求，对其中的临床文献按不同类别提出了文献评价方法并逐条文献进行了评价评分。专家问卷调查采用国际广泛应用的 Delphi 法为基础加以改良，结合中医药行业的具体情况，采用了具有代表性权威性的调查专家遴选办法、各轮问卷的形成方法、答卷数据处理的统计分析方法，使之成为有效凝聚专家共识的方法。

按中医药标准化研究中规定的“专家会议法”要求，邀请了以中医骨科学专家为主，相关药学、方法学专家等组成的专家论证组召开专家论证会，就项目工作组通过文献研究、专家问卷调查形成的指南草稿，特别是其中存有争议、有待讨论、商榷的内容，请专家们给出较客观的和专业化的意见，形成本指南标准初稿。

2.1.2 实用性

本指南制订的目的主要是促进国内、外股骨头坏死中医疗效评价标准的规范化，为股骨头坏死中医疗效评价的临床实践提供可靠证据，确保治疗的安全性和有效性。使医护人员全面了解相关知识、易于实际操作，能在股骨头坏死的医疗工作中得到广泛的实际应用。

在指南研制过程中，查找了相关的现代大量的中医与中西医结合临床报道、学术著作与教材等，将相关论述经文献综述形成的参评因子组成调查问卷，调查了分布于全国各地区股骨头坏死的专家，集中他们的意见，再经过专家论证和同行业专家广泛征求意见，使本指南从研制过程到结果保证了其实用性和可操作性。

2.1.3 规范性

本指南在研制过程中，均按照国家中医药管理局政策法规与监督司、中华中医药学会的要求。所采用的技术方法，包括文献检索和文献评价方法、专家问卷调查方法、专家论证会方法等，均按照国际比较公认的方法进行。保证了本指南的研制方法，包括技术方法及形成的指南规格体例、名词术语、语言文字等的规范性要求。

2.2 确定标准主要内容的论据

2.2.1 标准的主要内容

《股骨头坏死中医疗效评价标准》共有 4 个组成部分：范围、规范性引用文件、术语及定义、股骨头坏死中医疗效评价标准。

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 股骨头坏死中医疗效评价标准

4.1 功能评价

（1）VAS 视觉模拟评分

（2）髋关节屈曲评分

（3）行走距离评分

（4）评价计分方法

4.2 影像评价

2.2.2 确定标准主要内容的方法和依据

本标准的制定主要采用“文献研究法”、“专家问卷调查法（Delphi 法）”、“专家会议法”三法合一的研究方法。制定过程经历了四次专家论证会，七轮问卷调查，一次行业专家征求意见。综合专家意见反复修改完善，最后形成送审稿。

2.2.2.1 文献研究

（1）相关教材书籍：通过对超星数字图书馆及中国中医科学院图书馆所藏书籍进行查阅，利用纳排标准对书籍进行整理，检索到中医骨伤科学、中医骨病学教材等书籍。

（2）股骨头坏死与疗效评价标准：ZY / T001.1-94 《中医病证诊断疗效标准》；国家药品监督管理局修订，并于 2002 年发布的《中药新药临床研究指导原则》；GB/T 1.1—2009《标准化工作导则——第 1 部分：标准的结构和编写》；《基于 X 线的股骨头坏死保髋疗效评价方法研究》；《股骨头坏死临床诊疗规范(2015 年版)》；《成人股骨头坏死临床诊疗指南(2016)》；《Committee on Terminology and Classification》;《Traumatic

Arthritis of the Hip after Dislocation and Acetabular Fractures: Treatment by Mold Arthroplasty》。

（3）期刊文献：通过文献计量研究方法搜集统计分析《中国学术期刊全文数据库》（CNKI）、《中国生物医学文献数据库（CBMdisk）》、《中文科技期刊数据库（全文版）》、MEDLINE 数据库中收录的涉及中医药疗法治疗股骨头坏死的疗效评价文献。

制定一套明确的文献纳入与排除标准，对文献进行筛选，阅读符合标准的文献。纳入文献主要选择：已发布的指南、规范、标准及教材，以及随机对照研究、半随机对照研究、名老中医专家经验等。排除文献为不足以影响临床的理论探讨，设计不好及写作较差的临床报道，非名老中医的、未取得广泛共识的自拟方的临床报道。

（4）检索结果：检索结果：共检索到中文文献 8586 篇，剔除重复文献后所得到的文献数量 1581 篇，阅读题目和摘要，剔除综述、动物实验研究、理论探讨、会议通知，得到的文献数量为 662 篇，全文阅读后，共纳入符合标准文献 662 篇。

2.2.2.2 问卷调查

专家问卷调查采用国际广泛应用的 Delphi 法，撰写专家调查问卷，向遴选出的专家作两轮问卷调查。专家遴选的标准：目前领域具有一定权威性的临床专家，包括部分文献研究学者在内，精通本学科的业务，有一定的知名度、具有高级职称和长期

临床工作经验、有兴趣和能够坚持完成数轮专家调查，遴选专家时同时考虑到专家分布的地域性。他们是：朱俊峰、周明旺、赵德伟、张善星、张明雪、张伯松、詹红生、袁普卫、阎作勤、许鹏、邢更彦、谢雁鸣、王智勇、王天芳、王庆普、王和鸣、童培建、田华、孙伟、沈计荣、商洪才、彭江、卢敏、刘又文、刘保一、林娜、李子荣、李振华、李学民、李盛华、李少华、李劲峰、冷向阳、康鹏德、靳英辉、金今、焦锋、纪泉、黄野、黄相杰、黄枫、胡永成、何伟、韩永台、杜炯、董晓俊、陈卫衡、陈棉智、陈继营等专家。对专家答卷的统计分析，采用 Excel 表格录入数据，按照数据统计结果分析汇总专家意见，最后总结形成了《股骨头坏死中医疗效评价标准》初稿。

2.2.2.3 专家论证会

初稿完成后，项目组于 2018 年 7 月初项目工作组于北京再次召开专家论证会，邀请 30 位中医骨科学、中药学、方法学等专家对初稿论证。会议就工作组提出的标准初稿和相关问题进行了研讨，对其中的技术内容进行充分论证，对初稿提出了进一步修改的意见。对于初稿中的若干具体内容，专家们通过讨论基本上达成共识，提出了许多有价值的修改意见。2018 年 8-10 月项目工作组在修改初稿的基础上形成了最终的征求意见稿。

2.2.2.4 同行征求意见

《股骨头坏死中医疗效评价标准》项目工作组于 2018 年 11 月 25 日向全国承担过与标准相关的国家和行业中医药科研项目

的单位、参与本项目制订工作的单位、与标准相关的学术团体的成员单位的专家发放征求意见表。邀请 15 位中医骨科学、中药学、方法学等专家对征求意见稿进行讨论表决。共发放征求意见表 15 份，收回 15 份。13 位专家一致投票同意通过《股骨头坏死中医疗效评价标准》最终的征求意见稿。

3. 与相关法律、法规和强制性标准的关系

本项目工作组研究形成的《股骨头坏死中医疗效评价标准》与现行法律、法规和强制性标准没有冲突，并且在编制过程中严格遵循已有的国际、国内标准，使文本内容符合规范，言之有据。

4. 重大意见的处理经过和依据

在制定本标准过程中，项目组成员将难以解决的问题加以汇总，形成调查问卷，以电子问卷形式发送给相关专家，采用德尔菲(Delphi)法进行调研，并对专家意见进行了结果分析，采纳评分较高的意见。对于仍然无法解决的问题，项目组则通过专家共识会的方式，取得专家的一致性意见。编制过程中，项目组力求规范中涉及到的内容都有高质量的证据支持，让我们制订的规范标准每一项条目都有据可依。

4.1 德尔菲法专家意见集成

项目工作组在文献研究总结研讨后，采用 Delphi 法，撰写专家调查问卷，向按标准遴选出的专家作四轮问卷调查。专家遴选的标准：在骨科领域具有一定权威性的临床专家，包括部分文献研究学者在内，精通本学科的业务，有一定的知名度、具有高

级职称和长期临床工作经验、有兴趣和能够坚持完成数轮专家调查，遴选专家时同时考虑到专家分布的地域性。他们是：朱俊峰、周明旺、赵德伟、张善星、张明雪、张伯松、詹红生、袁普卫、阎作勤、许鹏、邢更彦、谢雁鸣、王智勇、王天芳、王庆普、王和鸣、童培建、田华、孙伟、沈计荣、商洪才、彭江、卢敏、刘又文、刘保一、林娜、李子荣、李振华、李学民、李盛华、李少华、李劲峰、冷向阳、康鹏德、靳英辉、金今、焦锋、纪泉、黄野、黄相杰、黄枫、胡永成、何伟、韩永台、杜炯、董晓俊、陈卫衡、陈棉智、陈继营等专家。对专家答卷的统计分析，汇总各专家的意见，再总结形成了《股骨头坏死中医疗效评价标准》标准初稿。

详见附件 1：《股骨头坏死中医疗效评价标准》专家问卷调查报告

4.2 专家论证会

《股骨头坏死中医疗效评价标准》草稿完成后，项目组于 2018 年 7 月在北京再次召开专家论证会，邀请 30 位中医骨伤学、中药学、方法学等专家对草稿论证，他们是：陈卫衡、陈继营、杜炯、韩永台、胡永成、黄枫、黄相杰、焦锋、靳英辉、金今、纪泉、冷向阳、李少华、李学民、李子荣、李振华、刘保一、林娜、刘又文、卢敏、孙伟、田华、王庆普、王智勇、邢更彦、袁普卫、詹红生、张伯松、赵德伟、周明旺。会议就工作组提出的指南草稿和相关问题进行了研讨，对其中的技术内容进行充分论

证，对草稿提出了进一步修改的意见。对于草稿中的若干具体内容，专家们通过讨论基本上达成共识，提出了许多有价值的修改意见。2018 年 11 月项目工作组在修改征求意见稿的基础上，在北京邀请相关专家，召开专家论证会，对征求意见中相关问题进行讨论，会后形成了《股骨头坏死中医疗效评价标准》送审稿。

详见附件 2：《股骨头坏死中医疗效评价标准》专家论证会会议纪要

4.3 行业专家征求意见

《股骨头坏死中医疗效评价标准》项目工作组于 2018 年 11 月向全国承担过与指南相关的国家和行业中医药科研项目的单位、参与本项目制订工作的单位、与指南相关的学术团体的成员单位的专家发放征求意见表。截止至 2018 年 11 月，共发放征求意见表 15 份，收回 15 份。问卷回收 100%,专家积极系数 100%。项目工作组按照“循证”等原则逐条讨论了专家们的意见，提出了采纳、不采纳的意见及理由，以之为依据，对指南进行修改。

详见附件 3：《股骨头坏死中医疗效评价标准》同行评价征求意见总结

5. 贯彻标准的要求和措施建议

本项目研制形成的《股骨头坏死中医疗效评价标准》经审查批准发布后，需要采用多种渠道宣传、贯彻、实施。

①由国家中医药管理局统一组织行业内的推广和贯彻实施工作。

②举办指南应用推广培训班、继续教育学习班，培训股骨头坏死中医疗效评价标准，促进指南的宣传、推广和应用。

③在学术杂志上发表指南及相关的学术论文，宣传、推广，并吸收进一步完善的意见。

6. 应当说明的其他事项

建议在本指南发布实施 3-5 年后，要依据临床研究的进展和技术方法的进步，对本指南进一步补充、制订、更新。

附件 1 专家调查问卷总结

附件 2 专家论证会

附件 3 同行征求意见总结

附件 1

《股骨头坏死中医疗效评价标准》专家调查问卷总结

时间：于 2017 年 7 月-2018 年 11 月

方法：专家问卷调查主要采用国际广泛应用的 Delphi 法为基础加以改良，进行专家问卷调查。

对象:先后通过 6 轮现场及 2 轮电子问卷共发放 254 份问卷，收回 251 份问卷，共 149 位中医专家与 102 位西医专家参加问卷调查，专家积极系数 98.81%。并于草案讨论会后根据专家建议对 103 位股骨头坏死患者与 72 位医师进行问卷调查，记录 200 例股骨头坏死患者关节活动度。调查专家专家名单如下：朱俊峰、周明旺、赵德伟、张善星、张明雪、张伯松、詹红生、袁普卫、阎作勤、许鹏、邢更彦、谢雁鸣、王智勇、王智勇、王天芳、王庆普、王和鸣、童培建、田华、孙伟、沈计荣、商洪才、彭江、卢敏、刘又文、刘保一、林娜、李子荣、李振华、李学民、李盛华、李少华、李劲峰、冷向阳、康鹏德、靳英辉、金今、焦锋、纪泉、黄野、黄相杰、黄枫、胡永成、何伟、韩永台、杜炯、董晓俊、陈卫衡、陈棉智、陈继营等专家。

结果：项目组对所有专家问卷及建议进行了归纳和整理。

对专家答卷的统计分析，采用 Excel 表格录入数据，按照数

据统计结果分析汇总专家意见，总结讨论所有专家提出的意见。专家们基本认可问卷中的内容，对一些具体问题提出了自己的意见。专家对各项问题的赞同率：被调查专家对股骨头坏死中医疗效评价标准均给出了赞同意见。专家提出的主要问题有：Harris 评分并不适用于保髋治疗，疼痛在股骨头坏死疗效中非常重要，比重应该最高等改进建议。专家对问题认定的重要程度：被调查对象对问卷中所设定的问题大部分都给出了“很重要”的评价。专家对问题的熟悉程度：绝大多数的被调查专家对问卷中的各个专业问题都是熟悉及比较熟悉。

具体专家意见如下：

（1）综合评价与分项目评价人数相当。

（2）综合评价权重 Harris、VAS、影像占比人数居多。

（4）分项目评价专家多数认为 Harris 髋关节功能评分比较重要。

（5）疼痛在股骨头坏死疗效中非常重要，比重应该最高

（7）多数专家认为主症应以疼痛为主，次症应以全身症状为主

（8）72 名各成员单位医师认为最能反应股骨头坏死疗效的指标结果显示排名前 5 位的疗效评价指标依次是疼痛，关节活动，X 线表现，行走距离，跛行

（9）103 名各成员单位门诊与住院患者最关心的股骨头坏死疗效指标结果显示排名前 5 位的疗效评价指标依次是疼痛，关节活动，行走距离，跛行，X 线表现。

（10）200 名（248 髋）中国中医科学院望京医院门诊与住院患者髋关节屈曲与总活动度调查结果显示，随着髋关节屈曲度数的下降髋关节总活动度也随之减小。

《股骨头坏死中医疗效评价标准》项目工作组

2019 年 2 月 26 日

附件 2

《股骨头坏死中医疗效评价标准》项目启动会

会议时间：2017 年 8 月 13 日

会议地点：北京西藏大厦

参会专家：房书亭、杨荣臣、王桂华、朱立国、郭宇博、沈志秀、陈卫衡、陈棉智、董晓俊、杜炯、韩永台、何伟、黄枫、黄野、焦锋、金今、康鹏德、李劲峰、李少华、李盛华、李学民、林娜、刘保一、刘又文、彭江、商洪才、沈计荣、孙伟、王和鸣、王天芳、王智勇、谢雁鸣、邢更彦、许鹏、阎作勤、詹红生、张善星、张明雪、赵德伟、朱俊峰。

项目组组长：陈卫衡

《股骨头坏死中医疗效评价标准》项目工作组组长陈卫衡教授向各位专家汇报了本项目组的工作情况。会议上专家积极发言，对本标准给予了肯定，对于项目组提出的若干问题，专家们进行了认真的讨论，并提出了对编制指南的意见，主要内容有：

（1）股骨头坏死中医疗效评价标准主证应为疼痛和活动度，次证为舌脉。

（2）股骨头坏死中医疗效评价标准如综合评价疼痛、髋关节功能、生活质量应占到 70%，影像学、中医证候、临床症状评价占 30%，疗效评价标准主证应包括疼痛、功能、行走距离。

（3）中医疗效评价指标应选症状评价分，能体现中药医疗效特点的量表。

（4）股骨头坏死中医疗效评价标准应综合评价

《股骨头坏死中医疗效评价标准》项目工作组

2017 年 8 月 13 日

《股骨头坏死中医疗效评价标准》草案专家讨论会（北京）

会议时间：2018 年 3 月 10 日

会议地点：北京亮马桥大厦

参会专家：王桂华、高学敏、朱立国、张抗、李磊、陈卫衡、陈棉智、陈耀龙、董晓俊、杜炯、韩永台、黄枫、何伟、焦锋、靳英辉、金今、康鹏德、李少华、李盛华、李子荣、林娜、林燕萍、刘又文、卢敏、彭江、商洪才、沈计荣、思金华、孙建宁、孙伟、田华、王和鸣、王平、王庆普、王天芳、王智勇、谢雁鸣、许鹏、严世贵、杨述华、喻佳洁、袁普卫、詹红生

项目组组长：陈卫衡

《股骨头坏死中医疗效评价标准》项目工作组组长陈卫衡教授向各位专家汇报了本项目组的工作情况。并对专家咨询本标准草案的意见。会议上专家积极发言，专家们进行了认真的讨论，基本上达成共识，并提出了修改意见，主要内容有：

（1）疗效评价标准不应局限于现有的评价标准组合，可以根据临床需要来创新。

（2）疗效评价标准应该多征求临床一线大夫意见建议。

（3）疗效评价标准应充分听取患者的意愿。

（4）Harris 髋关节功能评分是针对髋关节置换患者制定的评分标准，部分选项并不适用于股骨头坏死患者的疗效评价。

（5）Harris 评分高低不能直观的显示患者疼痛与关节功能的优劣，其显示度不足。

专家们经认真评议，认为《股骨头坏死中医疗效评价标准》草案已基本成形，项目工作组可就以上问题认真核查，少数欠妥当之处进行修改，部分评价指标需要酌情替换。

《股骨头坏死中医疗效评价标准》项目工作组

2018 年 3 月 10 日

《股骨头坏死中医疗效评价标准》专家咨询会（北京）

会议时间：2018 年 5 月 6 日

会议地点：北京民航国际会议中心

参会专家：房书亭、杨荣臣、王桂华、朱立国、郭宇博、沈志秀、陈卫衡、陈棉智、董晓俊、杜炯、韩永台、何伟、黄枫、黄野、焦锋、金今、康鹏德、李劲峰、李少华、李盛华、李学民、林娜、刘保一、刘又文、彭江、商洪才、沈计荣、孙伟、王和鸣、王天芳、王智勇、谢雁鸣、邢更彦、许鹏、阎作勤、詹红生、张善星、

张明雪、赵德伟、朱俊峰

项目组组长：陈卫衡

《股骨头坏死中医疗效评价标准》项目工作组组长陈卫衡教授向各位专家汇报了 3 月 10 日草案专家讨论会中专家们提出的修改意见回复，并向专家们征求了本次修改草案疗效评价的意见，会议上专家积极发言，专家们进行了认真的讨论，基本上达成共识，并提出了修改意见，主要内容有：

（1）股骨头坏死疗效应区分疼痛与关节功能独立进行评价。

（2）关节动能的优劣可选择主要活动方向即髋关节屈曲度表示。

（3）疼痛比较重要，权重最高。

（4）行走距离作为患者与医生关心的指标，都应纳入到评价标准中。

（5）临床症状体征等评价方法应与影像区分评价。

专家们经认真评议，认为《股骨头坏死中医疗效评价标准》草稿已基本成形，项目工作组可就以上问题认真核查，少数欠妥当之处进行修改，就可以形成《股骨头坏死中医疗效评价标准》初稿，经专家指导组论证后向医疗机构、科研机构、教育机构、行业组织及专家学者等各方面征求意见。

《股骨头坏死中医疗效评价标准》项目工作组

2018 年 5 月 06 日

《股骨头坏死中医疗效评价标准》专家论证会（北京）

会议时间：2018 年 7 月 21 日

会议地点：北京丽都维景酒店

参会专家：陈卫衡、陈继营、杜炯、韩永台、胡永成、黄枫、黄相杰、焦锋、靳英辉、金今、纪泉、冷向阳、李少华、李学民、李子荣、李振华、刘保一、林娜、刘又文、卢敏、孙伟、田华、王庆普、王智勇、邢更彦、袁普卫、詹红生、张伯松、赵德伟、周明旺

项目组组长：陈卫衡

《股骨头坏死中医疗效评价标准》项目工作组组长陈卫衡教授向各位专家汇报了本项目组的工作情况。并对专家征求对初稿的修改意见。会议上专家积极发言，专家们进行了认真的讨论，基本上达成共识，并提出了部分修改意见，主要内容有：

（1）行走距离不能单纯代表效果好，主要是无痛状态下的行走距离

（2）核磁对股骨头坏死早期诊断最敏感，应纳入到疗效评价指标

（3）行走距离应明确是徒手走路还是借助工具

（4）屈曲大致可以代表总活动度

（5）疗效评价应命名及验证

（6）影像考虑增加 CT

（7）应突出中医中药特色，使标准突出中医保髋特色

（8）标准的确定需要所有专家投票

专家们经认真评议，认为《股骨头坏死中医疗效评价标准》初稿已基本成形，项目工作组可就以上问题认真核查，少数欠妥当之处进行修改，就可以形成《股骨头坏死中医疗效评价标准》征求意见稿，经专家指导组论证后向医疗机构、科研机构、教育机构、行业组织及专家学者等各方面征求意见。

《股骨头坏死中医疗效评价标准》项目工作组

2018 年 7 月 21 日

《股骨头坏死中医疗效评价标准》征求意见表决会（北京）

会议时间：2018 年 11 月 25 日

会议地点：北京丽都维景酒店

参会专家：陈卫衡、董晓俊、韩永台、靳英辉、金今、纪泉、焦锋、李子荣、林娜、刘又文、卢敏、彭江、童培建、王庆普、王智勇、袁普卫、詹红生、张伯松

项目组组长：陈卫衡

《股骨头坏死中医疗效评价标准》项目工作组组长陈卫衡教授向各位专家汇报了本项目组的工作情况。邀请 18 位中医骨科学、中药学、方法学等专家对征求意见稿进行讨论表决。共发放征求意见表 15 份，收回 15 份。13 位专家一致同意投票通过《股

骨头坏死中医疗效评价标准》最终的征求意见稿。会议上专家积极发言，专家们进行了认真的讨论，基本上达成共识，并提出了修改意见，主要内容有：

（1）疼痛与行走距离比较重要性，X 线不足以说明问题增加 CT。

（2）活动度可以用屈曲加上旋转加上内外展。

（3）屈曲比较重要，应该占比较大

（4）明确功能和结构的关系，临床积分的方法应该细化

（5）影像学考虑增加 MR

《股骨头坏死中医疗效评价标准》项目工作组

2018 年 11 月 25 日

附件 3

《股骨头坏死中医疗效评价标准》同行征求意见总结

《股骨头坏死中医疗效评价标准》项目工作组于 2018 年 11 月向全国承担过与标准相关的国家和行业中医药科研项目的单位、参与本项目制订工作的单位、与标准相关的学术团体的成员单位的专家发放征求意见表。调查单位如下：中国中医科学院望京医院、河北医科大学第三附属医院、北京协和医院、北京医院、广州市中西医结合医院、中日友好医院、中国中医科学院中药研究所药性理论中心、洛阳正骨医院、湖南中医药大学第一附属医院、301 医院骨科研究所、浙江省中医院、北京中医药大学第三附属医院、中医正骨杂志、陕西中医药大学附属医院、上海曙光医院、北京积水潭医院。调查专家如下：陈卫衡、韩永台、金今、纪泉、焦锋、李子荣、刘又文、卢敏、彭江、童培建、王庆普、王智勇、袁普卫、詹红生、张伯松。

截止至 2018 年 11 月，共发放征求意见表 15 份，收回 15 份，提出相关问题 5 条。项目工作组按照“循证”等原则逐条讨论了专家们的意见，提出了采纳、不采纳的意见及理由，以之为依据，对标准进行修改。

《股骨头坏死中医疗效评价标准》项目工作组

2019 年 2 月 26 日